

Información Paciente

Nombre : Jose Luis Lara Droguett	Rut : 13.486.176-2	N° Archivo : 2410283	N° Epicrisis
Edad : 46a 5m 10d	Fecha Nacto : 16/02/1978	Sexo : Masculino	407800
Dirección : Av. Observatorio 0506 Villa José Donoso	Comuna : La Pintana	Teléfono : 9 3297 3683	

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Utim (5to Piso Mater)	Fecha Ingreso : 08/05/2024	17:28	Días Estadía : 79
Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto	Fecha Egreso : 26/07/2024	15:07	

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

tumor pulmonar / seminoma / Quimioterapia

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Ingreso HSR
Ingreso UCI 08/05/24
11/05/24 Días de Hospitalización
Días en UCI 74
71
CULTIVOS: 19.7 Clos. Dificile Toxina AB (-) GDH (-)
14.7 URO (-) / Hongos C. Albicans
11.7 HMCx2 (-) / Galactomanano 0.09 (-)
06.7 HMCx2 (1) E. Faecium Van B
06.7 PC KPN Blee NDM
06.7 URO C. Albicans
04.7 HMCx2 kpn Blee NDM
03.7 AT C. Albicans
28.6 HMCX2 (1) e. Faecium Van B (S LINEZOL)
27.6 Galactomanano 0.43 (-)
24.6 HMCx1 Staphilococo Pettenkoferi
24.6 HMCx1 Staphilococo Pettenkoferi
24.6 Panel Viral (-)
24.6 AT C. Albicans 340.000 UFC
24.6 Toxina Clostridium (-)
20.6 AT P. Pneumoniae Blee NDM
05.6 URO E. Faecium Van B / C. Albicans
05.6 HMCx2 S. Haemolyticus / E. Faecalis
05.6 AT C. Albicans
02.6 AT KPN Blee NDM / C. Albicans
02.6 URO C. albicans
21.5 RETRO (1) KPN Blee NDM
21.5 AT KPN Blee NDM / E. Coli ms / SAMS / C. Albicans
13.5 HR KPN NDM
12.5 AT S. Auereus (S) CLOXA/TMS Antibiótico

Fecha Epicrisis : 26/07/2024 15:00

QmTp BEP FI 10/5 (1° CICLO)

Días 1,2,3,4,5,9,16

QmTp BEP FI 11/06 (2° CICLO)

Días 1,2,3,4,5,9,16

QmTp BEP FI 15/07 (3° CICLO)

Días 1,2,3,4,5,9,16

AZTREONAM (17)

CEFTA AVIBACTAM (17)

LINEZOLID (20)

CLORANFENICOL OFT

VANCOMICINA VO

BLEOMICINA(+21) ETOPOSIDO (5/5)

CISPLATINO (5/5)

Filgastim (10/10) - \$

BLEOMICINA (2/9/16) ETOPOSIDO (5/5)

CARBOPLATINO (2)

Filgastim (10/10) - \$

BLEOMICINA (2/9/16) ETOPOSIDO (5/5)

CARBOPLATINO (2)

Filgastim (3(10)

DIAGNÓSTICOS:

5. Tumor mediastínico de Células Germinales, impresiona no seminoma en QT BEP con intención curativa

a. Tumor Mediastínico Células Germinales (IHQ: SALL (+), OCT-4 (+), CK AE1/AE3 (+), PLAP (-), AFP (-) BHCG (-), CD30 (-), CD45 (-), S100(-)

b. Sd de vena cava superior ¿ Trombosis tumoral de subclavia izquierda

c. 10/05/24 QmTp (primer CICLO) BEP

6. Insuficiencia Respiratoria Aguda

a. Derrame pleural derecho paraneoplásico

b. Pleurostomía (TAP debito 800 ml) - desplazado y retiro 16.5

c. Factor restrictivo por tumor mediastínico gigante

d. IOT/ARM 11.05.24

7. 12.05 NAC por SAMS

8. EVOLUCION / INTERCURRENCIAS

NEUTROPENIA FEBRIL

¿ 12.5 NAVM temprana x SAMS (Cloxacilina y previamente vancomicina)

¿ 15.5 ITU x E.Coli MS (Amikacina desde 15/05)

¿ 19.5 TC TORAX control (Derrame pleural moderado derecho / presencia de masa neoplásica derecha ¿ leve disminución de tamaño, se evidencia permeabilidad de bronquio LSD).

¿ 23.5 SHOCK SEPTICO + FMO (Hemodinámico / Metabolico / Hepático / Hematológico)

o NEUTROPENIA FEBRIL PROFUNDA RAN 100 (Filgrastim) + Bacteremia x K. Pneumoniae NDM + NAVM x KPN Blee NDM / E. Coli ms / SAMS / C. Albicans - inicia CEFTA AVI + AZTREONAM + VORICONAZOL / ACICLOVIR).

Fecha Última Actualización: 26-07-2024 15:00:10

Página 3 de 4

- ¿ 24.5 AKI secundaria ¿ TRR
- ¿ 24.5 Neutropenia Febril profunda RAN 0 ¿ ONCOLOGIA suspende QmTp
- ¿ 28.5 Arritmia FAARV (Amiodarona / Bisoprolol)
- ¿ 02.6 URO C. albicans + NAVM x KPN Blee NDM (Tto Cumplido)
- ¿ 05.6 ITU x E. Faecium Van B + Bacteremia x S. Haemolyticus / E. Faecalis (S) LINE /VANCO
- ¿ 11.06.24 QmTP (segundo ciclo) BEP (cumplido día 16)
- ¿ 19.6 CONVULSION (EEG no epileptiforme / TC ENCEFALO sin lesión aguda)
- ¿ 20.6 Arritmia TPSV (Adenosina) ¿ Amiodarona
- ¿ 20.06 Shock Séptico x NAVM x k. pneumoniae Blee NDM (CEFTA AVIBACTAM)
- ¿ 21.6 TRICITOPENIA secundaria (LEU 800 / Hto 22 /Plaq 27000) ¿ Trasfunde Plaquetas
- ¿ 24.6 Bacteremia x Staphylococo Pettenkoferi
- ¿ 26.6 SHOCK Refractario (Noradrenalina /Adrenalina /Vasopresina)
- ¿ 28.6 SDRA moderado Decúbito PRONO x 72h (25-28.6) + recambio de TOT (x disfunción de CUF)
- ¿ 6/7 Bacteremia x E. Faecium Van B (S LINEZOLID)
- ¿ 6.7 IAC Bacteremica x KPN Blee NDM
- ¿ 13.7 TQT Percutánea
- ¿ 15.7 QmTp (tercer ciclo)
- ¿ 19.7 GASTROENTERITIS x Clostridium Dificile) ¿ VANCOMICINA
- ¿ 24.7 NEUTROPENIA Profunda / Shock Septico
- ¿ 26.07 Fallecimiento (13:54h) se comunica a familiares.

DIAGNÓSTICOS:

9. Tumor mediastínico de Células Germinales, impresiona no seminoma en QT BEP con intención curativa
 - a. Tumor Mediastínico Célu las Germinales (IHQ: SALL (+), OCT-4 (+), CK AE1/AE3 (+), PLAP (-), AFP (-) BHCG (-), CD30 (-), CD45 (-), S100(-)
 - b. Sd de vena cava superior ¿ Trombosis tumoral de subclavia izquierda
 - c. 10/05/24 QmTp (primer CICLO) BEP
10. Insuficiencia Respiratoria Aguda
 - a. Derrame pleural derecho paraneoplásico
 - b. Pleurostomía (TAP debito 800 ml) - desplazado y retiro 16.5
 - c. Factor restrictivo por tumor mediastínico gigante
 - d. IOT/ARM 11.05.24
11. 12.05 NAC por SAMS
12. EVOLUCION / INTERCURRENCIAS

NEUTROPENIA FEBRIL

- ¿ 12.5 NAVM temprana x SAMS (Cloxacilina y previamente vancomicina)
- ¿ 15.5 ITU x E.Coli MS (Amikacina desde 15/05)
- ¿ 19.5 TC TORAX control (Derrame pleural moderado derecho / presencia de masa neoplásica derecha ¿ leve disminución de tamaño, se evidencia permeabilidad de bronquio LSD).
- ¿ 23.5 SHOCK SEPTICO + FMO (Hemodinámico / Metabolico / Hepático / Hematológico)
- o NEUTROPENIA FEBRIL PROFUNDA RAN 100 (Filgrastim) + Bacteremia x K. Pneumoniae NDM + NAVM x KPN Blee NDM / E. Coli ms / SAMS / C. Albicans - inicia CEFTA AVI + AZTREONAM + VORICONAZOL / ACICLOVIR).
- ¿ 24.5 AKI secundaria ¿ TRR
- ¿ 24.5 Neutropenia Febril profunda RAN 0 ¿ ONCOLOGIA suspende QmTp
- ¿ 28.5 Arritmia FAARV (Amiodarona / Bisoprolol)
- ¿ 02.6 URO C. albicans + NAVM x KPN Blee NDM (Tto Cumplido)
- ¿ 05.6 ITU x E. Faecium Van B + Bacteremia x S. Haemolyticus / E. Faecalis (S) LINE /VANCO
- ¿ 11.06.24 QmTP (segundo ciclo) BEP (cumplido día 16)
- ¿ 19.6 CONVULSION (EEG no epileptiforme / TC ENCEFALO sin lesión aguda)
- ¿ 20.6 Arritmia TPSV (Adenosina) ¿ Amiodarona
- ¿ 20.06 Shock Séptico x NAVM x k. pneumoniae Blee NDM (CEFTA AVIBACTAM)
- ¿ 21.6 TRICITOPENIA secundaria (LEU 800 / Hto 22 /Plaq 27000) ¿ Trasfunde Plaquetas
- ¿ 24.6 Bacteremia x Staphylococo Pettenkoferi
- ¿ 26.6 SHOCK Refractario (Noradrenalina /Adrenalina /Vasopresina)

Fecha Epicrisis : 26/07/2024 15:00

Página 3 de 4

Fecha Última Actualización: 26-07-2024 15:00:10

Página 4 de 4

- ¿ 28.6 SDRA moderado Decúbito PRONO x 72h (25-28.6) + recambio de TOT (x disfunción de CUF)
- ¿ 6/7 Bacteremia x E. Faecium Van B (S LINEZOLID)
- ¿ 6.7 IAC Bacteremia x KPN Blee NDM
- ¿ 13.7 TQT Percutánea
- ¿ 15.7 QmTp (tercer ciclo)
- ¿ 19.7 GASTROENTERITIS x Clostridium Dificile) ¿ VANCOMICINA
- ¿ 24.7 NEUTROPENIA Profunda / Shock Septico
- ¿ 26.07 Fallecimiento (13:54h) se comunica a familiares.

Diagnóstico de Egreso

Nódulo Pulmonar en estudio - Tumor Pulmonar - SEMINOMA
Neutropenia febril - QUIMIOTERAPIA

Condición de Egreso

Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

FALLECIMIENTO 26.07.2024 13:45 H se informa a familiares

Plan Post Alta

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente



Juan Ulloa Mancero
Médico Tratante (Staff)